

• 标准与规范 •

艾滋病相关焦虑中西医协同治疗专家共识^{*}

中华中医药学会防治艾滋病分会

摘要: 焦虑是艾滋病患者最常见的心理症状之一,焦虑不仅增加了患者的治疗负担,更影响了患者的服药依从性和治疗效果。目前西医主要以心理辅导及抗焦虑抑郁药物治疗。中医对本病的认识多归于“惊悸”“怔忡”“不寐”“健忘”“郁证”等范畴,认为病位在脑,涉及多个脏腑,病情复杂。中医药与抗焦虑药物协同治疗,充分发挥中西药各自的治疗优势,临床疗效显著。

文献引用: 中华中医药学会防治艾滋病分会. 艾滋病相关焦虑中西医协同治疗专家共识 [J]. 中医学报, 2020, 35(9): 1889-1892.

关键词: 艾滋病; 焦虑; 惊悸; 怔忡; 郁证; 协同治疗; 专家共识

DOI: 10.16368/j.issn.1674-8999.2020.09.423

中图分类号: R259.129.1 **文献标志码:** A **文章编号:** 1674-8999(2020)09-1889-04

Expert Consensus on Collaborative Treatment of AIDS Related Anxiety with Chinese and Western Medicine

AIDS Prevention and Treatment Branch of China Association of Chinese Medicine

Abstract: Anxiety is one of the most common psychological symptoms among AIDS patients. Anxiety not only increases the treatment burden of patients, but also affects their medication compliance and treatment effect. At present, western medicine mainly treats this disease with psychological counseling and anti-anxiety and depression drugs. Chinese medicine often classifies the disease as "fright palpitation" "severe palpitation" "insomnia" "amnesia" and "depression syndrome". It is believed that the disease is located in the brain, involving multiple zang-fu viscera, and the condition is complex. Chinese medicine and anti-anxiety drugs are used in synergistic treatment to give full play to the advantages of Chinese and western medicines, and the clinical effects are significant.

Reference citation: AIDS Prevention and Treatment Branch of China Association of Chinese Medicine. Expert Consensus on Collaborative Treatment of AIDS Related Anxiety with Chinese and Western Medicine [J]. Acta Chinese Medicine, 2020, 35(9): 1889-1892.

Keywords: AIDS; AIDS related anxiety; fright palpitation; severe palpitation; depression syndrome; collaborative treatment; expert consensus

艾滋病是严重危害人类健康的传染病,由于其本身的凶险性和伴随的社会耻辱感,不仅造成患者躯体伤害,同时也在精神心理方面给患者带来严重的创伤,引起神经精神疾病^[1],包括焦虑、抑郁及躯体障碍等。焦虑、抑郁是在艾滋病患者中最常见的心理症状之一^[2-4]。研究发现,人类免疫缺陷病毒(human immunodeficiency virus, HIV)阳性患者比阴性患者焦虑、抑郁症的发病率高出2倍以上。焦虑、抑郁不仅增加了患者的治疗负担,更影响了患者的服

药依从性和治疗效果,且艾滋病抗病毒治疗延长了患者生命,但是患者发病后的无希望感、负罪感及恐惧感仍然存在^[5-8],加之不同程度的社会歧视因素,导致很多患者的致死原因是精神压抑。艾滋病患者的焦虑、抑郁是一个复杂的问题,尤其是长期高效抗逆转录病毒治疗(highly active antiretroviral therapy, HAART)的艾滋病患者此问题更为显著。目前西医治疗与心理辅导及抗焦虑抑郁药物治疗,引起肝肾功能损伤,增加患者用药负担,且临床效果不明显。

中医学没有焦虑障碍的病名,对本病的认识多在“惊悸”“怔忡”“不寐”“健忘”“百合病”“卑憊”

^{*} 基金项目: 中医药行业科技专项项目(201507005)

“灯笼病”“奔豚气”“郁证”等疾病的文献中进行论述。中医学认为,本病病位在脑,涉及多个脏腑,病情复杂,病因多由于思虑过度、情志不舒,日久则肝气郁结、心脾亏虚、肾精暗耗,一旦有外界的情绪刺激,则肝气郁而化火,扰及心神,耗伤心血,克伐脾土,伤及肾精,则见惊悸、怔忡、恐惧、怵惕思虑、烦躁易怒、夜寐不安诸症。治疗上多以疏肝理气、清热除烦、健脾益气、补心养血、滋肾填精为主要治法。

中医药治疗焦虑障碍具有一定的优势。中医学具有辨证论治的特点,善于从患者的体质出发,根据病情的变化判断其证候特点,再有针对性地进行个体化遣方用药。中药具有多靶点、多层次干预的特点,可以从多个途径对焦虑情绪起到治疗作用,且不良反应较少。临床疗效上,与5-羟色胺再摄取抑制剂类药物相比,具有起效快的优势,能够较快地改善焦虑情绪、睡眠障碍及各种躯体症状。与苯二氮卓类药物相比,具有疗效稳定、不易复发的优势。与抗焦虑药物同用,选择合适的时机进行干预,可以相得益彰,发挥中西药各自的治疗优势,而且能够减轻抗焦虑药物的不良反应,保护肝肾功能。艾灸、穴位贴敷、拔罐、按摩推拿等方法对于焦虑障碍的后期调养及预防复发具有较好的作用,能够改变患者的思维惯性及易患体质。

1 临床表现

HIV阳性者可能表现出强烈的心理反应,如绝望、愤怒、恐惧甚至自杀。焦虑的广泛性和持续性是广泛性焦虑障碍的核心症状,但不一定在某一特殊情境中发生,患者整日容易紧张,症状多变,一般包括以下要素。

1.1 担心和焦虑 广泛性焦虑障碍主要症状是担心和焦虑,这种担忧和担心是期待性的,与健康人的忧虑和担心相比,不可控制,持续时间长,涉及范围广。

1.2 高警觉性 易激惹、烦躁不安、肌肉紧张、注意力不能集中、睡眠障碍。这些症状常集中出现。

1.3 自主神经活动亢进和其他症状 坐立不安、颤抖、皮肤苍白出汗(尤其是双手、胸部、腋窝)、口干、心动过速/心悸、恶心或腹部不适等。

2 诊断要点

2.1 疾病诊断

2.1.1 艾滋病诊断标准 参照中华人民共和国国家标准《艾滋病和艾滋病病毒感染诊断》(WS293-2019)、中华医学会感染病学分会艾滋病丙肝学组制定的《中国艾滋病诊疗指南(2018版)》。

诊断原则: HIV/AIDS 的诊断需结合流行病学

史(包括不安全性生活史、静脉注射毒品史、输入未经抗 HIV 抗体检测的血液或血液制品、HIV 抗体阳性者所生子女或职业暴露史等)、结合抗 HIV 阳性,经 Western Blot 确证试验证实。

2.1.2 焦虑诊断标准 符合《中国精神障碍分类与诊断标准》第3版(CCMD-3)^[1]广泛性焦虑症的诊断标准。1)符合神经症的诊断标准。2)以持续的原发性焦虑症状为主,并符合下列2项:①经常或持续的无明确对象和固定内容的恐惧或提心吊胆;②伴自主神经症状或运动性不安。严重标准:社会功能受损,患者因难以忍受又无法解脱,而感到痛苦。病程标准:符合症状标准至少已6个月。3)汉密尔顿焦虑量表^[2]评分 ≥ 14 分。

2.2 证候诊断 参照《基于个体化的广泛性焦虑障碍中医临床实践指南》分为5个证候类型。

2.2.1 肝郁化火证 主症:心烦易怒。次症:失眠多梦,口苦咽干,脘腹不适,痞塞满闷,胸胁胀痛,咽中不适,如物梗阻,面红目赤,尿赤便秘。舌红,苔黄,脉弦数。

2.2.2 痰热扰心证 主症:心烦易怒。次症:紧张不安,痰多呕恶,少寐多梦,头晕头胀,口苦,便秘。舌红,苔黄腻,脉滑数。

2.2.3 心肾不交证 主症:心烦失眠。次症:心悸,头晕耳鸣,健忘,腰膝酸软,梦遗,潮热盗汗。舌红少苔,脉细数。

2.2.4 心胆气虚证 主症:善惊易恐。次症:坐卧不安,失眠多梦,易醒,胆怯心悸,气短,易自汗,倦怠乏力。舌淡或淡红,苔薄白,脉细。

2.2.5 心脾两虚证 主症:善思多虑。次症:心悸,胸闷,神疲,失眠,健忘,面色萎黄,头晕,倦怠乏力,易自汗,纳谷不化,便溏。舌质淡,苔白,脉细。

3 治疗原则及方案

3.1 西医疗法

3.1.1 抗病毒治疗 以第4版《国家免费艾滋病抗病毒药物治疗手册》为依据,以一线抗病毒治疗方案为主。

3.1.2 对症治疗,精神症状治疗 对严重影响生活质量和治疗依从性的临床证候群,精神药物治疗是有效的。在使用精神药物时,要特别留意药物相互作用,艾滋病药物除了抗病毒药物之外,很可能因各类感染或其他伴随躯体疾病同时应用多种药物。一些对药酶影响明显的药物应慎重使用,并以低剂量为妥。

苯二氮卓类药物:常用药物有阿普唑仑(常用剂量0.2~2.0mg)、劳拉西泮(常用剂量1.0~4.0mg)、艾司唑仑(常用剂量1.0~2.0mg)、地西泮(常用剂量5.0~20mg)、氯硝西泮(常用剂量

2.0~6.0 mg)。

本类药物主要用于广泛性焦虑,可改善睡眠,但不宜长期使用,一般只需3~6周。停药应缓慢减量。

5-羟色胺1A受体部分激动药:①选择性5-羟色胺再摄取抑制剂:帕罗西汀20~40 mg;舍曲林50~100 mg;西酞普兰20~40 mg、艾司西酞普兰10~20 mg。②5-羟色胺和去甲肾上腺素再摄取抑制剂:文拉法辛150 mg、度洛西汀30~60 mg。③去甲肾上腺素能和特异性5-羟色胺能抗抑郁药:米氮平10~30 mg。④5-羟色胺受体拮抗剂和再摄取抑制剂:曲唑酮100~200 mg;噻奈普汀12.5 mg,每日3次。⑤三环类抗抑郁药:丙咪嗪、阿米替林、氯米帕明、多塞平以及四环类马普替林。推荐剂量三环类抗抑郁药治疗指数低,剂量受镇静、抗胆碱能和心血管不良反应的限制。一般使用剂量为每天50~250 mg,剂量缓慢递增,分次服用。减药宜慢,突然停药可能出现胆碱能活动过度,从而引起失眠、焦虑、易激惹、胃肠道症状和抽搐等。

β -受体阻滞剂:普萘洛尔为代表,可有效减轻躯体性焦虑症状。每次口服10 mg,每日1次。单独用于治疗广泛性焦虑加量的作用有限。禁用于心脏传导阻滞、心动过缓、心功能不全、支气管痉挛、代谢性酸中毒及禁食的患者。

3.1.3 心理治疗 应针对HIV阳性者及艾滋病患者进行心理干预,不仅能改善患者生活质量,而且可以提高患者对抗病毒治疗的依从性,延长生存期。常用集体心理治疗,小组心理治疗,个别心理治疗,森田疗法。

3.2 中医治疗方案 确诊广泛性焦虑障碍的HIV/AIDS患者,中医以身心同治等思想为指导,给予包括中医心理治疗、辨证论治口服中药、中成药治疗、推拿按摩、足浴、贴敷等其他物理治疗在内的多项治疗方案,因人而异,实施个体化治疗。

3.2.1 辨证论治 辨证论治方面,本病因素体正虚,复为七情所伤,五脏气血阴阳不和,心神失养,脑神不利所致。病位在脑,涉及五脏,而以心、肝、脾、肾为主。本虚以心脾两虚、心胆气虚、心肾不交为主;标实以肝郁化火、痰热扰心为主。本病治疗时需区分发作期和缓解期。发作期多以气郁、痰火等实邪为主,缓解期则以虚证常见。实证以疏肝、解郁、清热、化痰等为主;虚证以养心、健脾、滋肝、补肾、益气等为主;但总以宁心安神为首。

肝郁化火证:治法:疏肝解郁,泻火安神。推荐方药:丹栀逍遥散《内科摘要》加减(A级推荐)。组成:牡丹皮、栀子、柴胡、当归、白芍、茯苓、白术、香附、川芎、远志、合欢皮、磁石、琥珀粉冲服。柴胡疏

肝散合小陷胸汤(A级推荐,IIa级证据)^[9];泻肝安神汤(A级推荐,IIb级证据)^[10]。

痰热扰心证:治法:清热化痰,和中安神。推荐方药:黄连温胆汤《六因条辨》加减(A级推荐)。组成:黄连、陈皮、香附、清半夏、茯苓、枳实、竹茹、白术、生龙骨、生牡蛎、远志。安神化痰汤(A级推荐,IIa级证据)^[11]。

心肾不交证:治法:滋阴降火,养心安神。推荐方药:黄连阿胶汤《伤寒论》合百合地黄汤《金匱要略》加减(A级推荐)。组成:黄连、阿胶(烔化)、白芍、黄芩、百合、生地黄、龙骨、远志、石菖蒲。酸枣仁汤(A级推荐,IIa级证据)^[12-13]。

心胆气虚证:治法:益气镇惊,定志安神。推荐方药:安神定志丸《医学心悟》加减(A级推荐)。组成:远志、石菖蒲、茯苓、龙齿(先煎)、党参、酸枣仁、五味子、甘草、淮小麦。十味温胆汤:枣仁、党参、半夏、陈皮、竹茹、枳实、茯苓、石菖蒲、远志、熟地黄、龙骨、牡蛎、炙甘草(A级推荐,IIb级证据)。

心脾两虚证:治法:补益气血,养心安神。推荐方药:归脾汤《济生方》加减(A级推荐)。组成:党参、白术、黄芪、茯苓、当归、酸枣仁、龙眼肉、木香、炙甘草、远志。

3.2.2 推荐中成药 逍遥丸,每次9 g,每天3次。用于肝郁脾虚所致的郁闷不舒、胸胁胀痛、头晕目眩、食欲减退、月经不调。

疏肝解郁胶囊,每次2粒,每天2次,早晚各1次。适用于轻、中度单相抑郁症属肝郁脾虚证者,症见情绪低落、兴趣下降、迟滞、入睡困难、早醒、多梦、紧张不安、急躁易怒、食少纳呆、胸闷、疲乏无力、多汗、疼痛。

神安胶囊,每次4粒(每粒0.25 g),早晚各1次。适用于心悸、健忘、失眠、多梦易惊、食少体倦、面色萎黄。

乌灵胶囊,每次3粒(每粒0.33 g),每天3次。适用于神经衰弱的心肾不交证,症见失眠、健忘、神疲乏力、腰膝酸软等。

天王补心丹,每次1丸,每天1次。适用于心悸失眠,虚烦神疲,梦遗健忘,手足心热,口舌生疮,舌红少苔,脉细而数。

参松养心胶囊,每次3粒,每天3次。适用于心悸不安、气短乏力,动则加剧,胸部闷痛,失眠多梦。

解郁丸,每次4 g,每天3次。适用于肝郁气滞,心神不安所致胸肋胀满,郁闷不舒,心烦心悸,易怒,失眠多梦。

九味镇心颗粒,每次1袋,每天3次。适用于善思多虑不解、失眠或多梦、心悸、食欲不振、神疲乏力、头晕、易汗出、善太息、面色萎黄。

舒眠胶囊,晚饭后及临睡前各服1次。用于失眠多梦,精神抑郁或急躁易怒,胸胁苦满或胸膈不畅,口苦目眩。

养血清脑颗粒,每次1袋,每天3次。用于血虚肝亢所致头痛、眩晕眼花、心烦易怒、失眠多梦等。

肉蔻五味丸,每次9~15粒,每天1~3次。用于心烦失眠,心神不安。

甜梦胶囊,每次3粒,每天2次。用于头晕耳鸣,视减听衰,失眠健忘,食欲不振,腰膝酸软,心慌气短。

3.2.3 推荐中医特色疗法 艾灸:选取关元、气海、足三里、命门、膻中、中脘、神阙等穴位,用艾条点燃靠近穴位,以温热为度,也可根据具体证候病情选择回旋灸、雀啄灸、温和灸等不同灸法,每次灸15~20 min。此法多适用于辨证属虚证患者。

耳针:根据患者具体病情,选取心、肝、脾、肾、肾上腺、内分泌、交感、神门等穴。治疗前先用耳穴探测棒在耳穴上寻找阳性点,用体积分数75%酒精消毒耳郭后,将王不留行籽用胶布固压于耳穴,给予施力加压,使患者有酸麻胀痛或发热感,并嘱患者定时按压,每天2~3次,每次3~5 min。

中药穴位贴敷:用酸枣仁、琥珀等。共研为细末。夜晚睡前,用温开水调敷双侧神门、神阙、安眠、三阴交、太溪、涌泉等,每次选择双侧2~4个穴位,留置8 h后揭下。

中药足浴:①实证方:夏枯草、栀子、磁石、代赭石水煎泡足,具有清热安神的功效。②虚证方:附子、丹参、吴茱萸、鸡血藤,水煎泡足,具有温阳安神的功效。操作方法:加水5 L煎煮约1 h,滤除中药渣,待温度适中,将双足浸泡药液中20~30 min,每日或隔日1次,视患者耐受程度决定。

拔罐:自项至腰部足太阳经背部侧线,用火罐自上而下走罐及闪罐,以背部潮红为度,最后在足太阳经背部侧线留罐10~15 min,2 d 1次。适用于偏实证患者。如患者皮肤过于敏感不能耐受,为预防皮损及感染,可多日1次,视情况而定。

按摩推拿疗法:依据辨证论治原则,根据患者的症状及耐受程度,可选择不同的推拿手法及穴位按摩方法,以头部按摩法为主,但皆以使患者情绪放松、稳定,减轻或消除心理上对疾病的不良反应为目的。

头部按摩法操作时,让患者仰卧,先用一指禅推法或揉法,从印堂开始上至神庭,往返5~6次,再由印堂沿两侧眉弓至太阳往返5~6次,然后用一指禅推法沿眼眶周围治疗,往返3~4次,再由印堂向下至鼻两侧经迎香沿颧骨再至双耳前往返3~4次。以印堂、神庭、睛明、攒竹、太阳为重点。嘱患者闭目,用双手拇指轻轻拂抹双眼睑数次,在头顶部用五

指拿法。

通过多年的临床实践观察,对于广泛性焦虑障碍患者,根据辨证论治的理论,首选心理治疗,其次为药物治疗,且针灸、推拿、按摩等非药物治疗方法有积极的意义。此处提供不便于按此前证候分型进行分类的治疗方法,以供参考,选择性应用。

执笔单位:新疆维吾尔自治区中医医院、首都医科大学附属北京地坛医院、中国中医科学院艾滋病中心

万勇、马成杰、马建萍、马秀兰、王丹妮、王军文、王丽、王莉、王健、毛宇湘、陆中云、杨玉琪、杨毅、何云、何金洋、何艳、谷野、邹雯、张传涛、张国梁、张明香、张晓忠、张毅、陈昕、陈耀凯、邵宝平、林路平、罗威、和丽生、胡建华、姜枫、徐立然、高辉、高国建、郭会军、黄成瑜、常占杰、梁碧颜、董继鹏、蒋士卿、喻剑华、谭行华、蔡怡

参考文献:

- [1] 于欣. HIV/AIDS 相关的精神卫生问题 [J]. 中国心理卫生杂志, 2000, 14(4): 247-250.
- [2] ASCH S M, KILBOURNE A M, GIFFORD A L, et al. Under diagnosis of depression in HIV: who are we missing [J]. J Gen Intern Med, 2003, 18(6): 450-460.
- [3] REISNER S L, MIMIAGA M J, CASE P, et al. Sexually transmitted disease(STD) diagnoses and mental health disparities among women who have sex with women screened at an urban community health center, Boston, MA, 2007 [J]. Sex Transm Dis, 2010, 37(1): 5-12.
- [4] PAPPIN M, WOUTERS E, BOOYSEN F L. Anxiety and depression amongst patients enrolled in a public sector antiretroviral treatment programme in South Africa: a cross-sectional study [J]. BMC Public Health, 2012, 12: 244.
- [5] LU F, WANG N, WU Z, et al. Estimating the number of people at risk for and living with HIV in China in 2005: methods and results [J]. Sex Transm Infect, 2006, 82(Suppl 3): 87-91.
- [6] 向德平, 陈琦. 艾滋病患者的社区支持 [J]. 学术论坛, 2004, 27(3): 141-144.
- [7] 中国精神障碍分类与诊断标准 [S]. 3版. 济南: 山东科学技术出版社, 2001: 89-90.
- [8] 张明园. 精神科评定量表手册 [M]. 2版. 长沙: 湖南科学技术出版社, 2003: 133-137.
- [9] 赵敬平. 柴胡疏肝散合小陷胸汤治疗广泛性焦虑症的临床观察 [J]. 中国中医药现代远程教育, 2010, 8(17): 121.
- [10] 张中发, 杨永超, 崔翠萍. 泻肝安神汤与坦度螺酮治疗广泛性焦虑症对照研究 [J]. 光明中医, 2011, 26(8): 1662-1663.
- [11] 朱冬胜. 安神化痰汤治疗广泛性焦虑症疗效观察 [J]. 上海中医药杂志, 2011, 45(7): 41-42.
- [12] 张景玉. 加味酸枣仁汤治疗广泛性焦虑障碍临床疗效观察 [J]. 光明中医, 2012, 27(11): 2256-2257.
- [13] 王琼. 酸枣仁汤治疗广泛性焦虑症临床研究 [D]. 广州: 广州中医药大学, 2012: 1-20.

收稿日期: 2020-03-25

编辑: 纪彬